

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	ASISTENSI PERSALINAN TINDAKAN PERVAGINAM DENGAN VACUM EKSTRAKSI		
	No. Dokumen 571.22/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Melakukan asistensi pada pertolongan persalinan dengan tindakan vacum ekstraksi yang dilakukan bila ada indikasi melahirkan bayi lewat vagina dengan jalan menyedot dan menarik kepala bayi memakai alat “ Vacum”		
Tujuan	1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pelaksanaan tindakan asisten pertolongan persalinan dengan tindakan pervaginam vakum ekstraksi 2. Mempercepat kala II atau memperpendek kala II atau mengakhiri kala II sesuai dengan indikasi 3. Agar tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, konsisten dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standart yang berlaku		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Bidan		
Prosedur	1. Dilakukan sesuai indikasi : 1. Memperpendek kala II 2. Kala II memanjang (kala II lama) 3. Gawat Janin 2. Dilakukan dengan syarat : 1. Presentasi belakang kepala 2. Janin cukup bulan 3. Pembukaan 7 cm pada multi gravida 4. Pembukaan lengkap atau hampir lengkap pada primi gravida 5. Kepala H III – IV atau 1/5 – 2/5 3. Kontra indikasi : 1. Malpresentasi 2. Ketuban sudah pecah / dipecahkan 3. Janin premature 4. Pembukaan belum lengkap 5. Kepala masih tinggi		
Prosedur	1. Siapkan alat 1.1. Siapkan alat meliputi : a. Vacum set b. Partus set c. Heacting set d. Resusitasi set e. APD (Celemek, masker, google, sepatu boot) f. Bethadine		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	ASISTENSI PERSALINAN TINDAKAN PERVAGINAM DENGAN VACUM EKSTRAKSI		
	No. Dokumen 571.22/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 3
Prosedur	g. Deppres h. Larutan chlorine 0,5% pada tempatnya 1.2. Dekatkan alat-alat di samping pasien 2. Lakukan persiapan klien/pasien 1. Lakukan 5 S (Senyum,Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 2. Perkenalkan diri, dokter yang melakukan tindakan 3. Identifikasi pasien 4. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan 5. Buat persetujuan / inform consent dan tanyakan persetujuan dan kesiapan pasien 6. Atur posisi pasien dalam posisi lithotomi 3. Siapkan lingkungan 1. Jaga <i>privacy</i> pasien 2. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman 4. Laksanakan tindakan 1. Lakukan 6 langkah cuci tangan sebelum tindakan. 2. Pakailah APD sesuai standart (Celemek, masker, kacamata <i>google</i>, sepatu boot dan sarung tangan) 3. Lakukan pengisapan vacum dengan tenaga 0,2 kg / cm persegi dengan interval 2 menit. Tenaga maksimal vacum yang diperlukan ialah 0,8 kg/cm persegi Saat ada his dan perineum tampak pucat, letakkan dua jari kiri kedalam Vagina diantara kepala bayi dan perineum. 4. Operator memeriksa apakah ada jaringan vagina yang terjepit. Jika ada turunkan tekanan dan lepaskan jaringan yang terjepit tersebut. 5. Setelah mencapai tekanan negatif yang adekuat operator melakukan traksi ke bawah searah dengan sumbu panggul dan tegak lurus pada mangkok. Asisten mempertahankan tekanan vacum 6. Operator melakukan tarikan pada saat puncak kontraksi uterus, Posisi tangan kanan luar menarik pengait, ibu jari tangan dalam pada mangkok , telunjuk dan jari tengah pada kulit kepala bayi. Asisten tindakan meminta pasien untuk mengejan. 7. Tarikan bisa diulangi sampai 3 kali saja oleh operator. Asisten melakukan pemeriksaan denyut jantung bayi antara 2 kontraksi uterus dan operator melakukan aplikasi 8. Asisten melakukan episiotomi 9. Saat sub oksiput sudah berada di bawah symphysis operator mengarahkan tarikan keatas hingga berturut-turut lahir dari, muka dan dagu. 10. Asisten membuka tekanan negatif dan operator melepaskan mangkok vacum		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	ASISTENSI PERSALINAN TINDAKAN PERVAGINAM DENGAN VACUM EKSTRAKSI		
	No. Dokumen 571.22/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
	11. Asisten membantu operator melanjutkan kelahiran bayi dan placenta dilakukan seperti pertolongan persalinan normal. 5. Rapihan pasien dan membereskan alat 1. Rapihan pasien dengan posisi yang nyaman 2. Bereskan alat-alat yang tidak digunakan 3. Lakukan 6 langkah cuci tangan setelah tindakan 6. Lakukan evaluasi dan dokumentasi 1. Eksplorasi jalan lahir menggunakan spekulum sim's untuk melihat apakah ada robekan pada dinding vagina atau perpanjangan luka episiotomi 2. Kriteria ekstraksi vacum gagal : a. Waktu dilakukan traksi mangkuk vacum terlepas 3 kali b. Dalam waktu 30 menit dilakukan traksi, janin belum berhasil dilahirkan. c. Bila terjadi kegagalan persalinan dilakukan dengan bedah sesar 3. Evaluasi hasil tindakan dan respon pasien 4. Sampaikan bahwa tindakan telah selesai dilakukan dan beri ucapan selamat pada ibu		
Unit Terkait	1. IGD 2. Ruang Bersalin		